KI-EINSATZ-PLANUNG · VERORDNUNGS-CHECK · GRUPPE 1

Kapitel 2: Mögliche KI-Einsatzbereiche analysieren

Physiotherapiepraxis (anonymisiert) · Fassung v2 (Entwurf zur Freigabe) · Stand 27.10.2026

Kapitel 1 hat gezeigt, wo in der Praxis Zeit verloren geht: Jede Kassenverordnung wird an der Rezeption von Hand geprüft, und die meisten Fehler entstehen bei Folgeverordnungen, die niemand im Überblick hat. Bevor wir uns für eine Lösung entscheiden, betrachten wir in diesem Kapitel alle Arbeitsbereiche beider Standorte. Wir prüfen, wo KI einen echten Beitrag leisten kann, wo eine feste Regel oder ein Mensch besser geeignet ist und welcher Bereich als erster umgesetzt wird.

1 Vorgehen

Wir haben die drei Arbeitsbereiche Rezeption, Therapie und Verwaltung nacheinander durchgegangen, jeweils für die GKV-Praxis und die Privatpraxis. Für jeden Bereich haben wir die Tätigkeiten gesammelt, die regelmäßig anfallen, viel Zeit kosten oder fehleranfällig sind. Daraus ergeben sich sieben mögliche Einsatzfelder.

Jedes Feld wird auf zwei Achsen eingeordnet. **Nutzen:** Wie viel Zeit spart es, welche Fehler vermeidet es, wie stark entlastet es die Rezeption? **Machbarkeit:** Liegen die nötigen Daten vor, geht es ohne Schnittstelle zur Praxissoftware, und wie hoch ist das Risiko bei Datenschutz und Fehlentscheidungen? Die Einordnung ist eine Einschätzung des Teams auf Grundlage der Field Study, keine Messung. Überprüft wird sie im Pilot für den gewählten Bereich.

2 Zwei Standorte, zwei verschiedene Probleme

Die Organisation der Praxis hat eine Besonderheit, die für die Analyse entscheidend ist: zwei Praxen an zwei Standorten, eine für gesetzlich Versicherte, eine für Privatpatienten, aber eine zentrale Terminvergabe für beide.

	GKV-Praxis (Praxis 1)	Privatpraxis (Praxis 2)
Grundlage	Verordnung auf Muster 13 nach Heilmittel-Richtlinie	kein einheitliches Formular, keine Fristen, keine Höchstmengen
Preis	vertraglich festgelegt	legt die Praxis weitgehend selbst fest
Risiko	Absetzung durch die Kasse, das Risiko trägt die Praxis	Erstattungslücke, das Risiko trägt der Patient
Folge für KI	Regelprüfung gegen öffentliche Regelwerke	Information über Kosten und Erstattung vor Behandlungsbeginn

Der Verordnungs-Check lässt sich deshalb nicht einfach auf die Privatpraxis übertragen. Dort hängt die Erstattung vom Tarif der Patientin ab, oft mit der Bundesbeihilfeverordnung als Orientierung. Das ist eine andere Tätigkeit, und sie braucht einen anderen Ansatz.

3 Die Einsatzfelder im Einzelnen

Einsatzfeld	Möglicher Beitrag der KI	Nutzen	Machbarkeit
E1 Verordnungs-Check Rezeption, Praxis 1	Angaben erfassen, gegen Heilmittel-Richtlinie, Heilmittelkatalog und KBV-Diagnoseliste prüfen, Ampel mit Fundstelle zeigen; Einheiten früherer Verordnungen im selben Fall summieren	**hoch:** trifft 90 % der Fehler und den größten Zeitblock der Rezeption	**hoch:** öffentliche Regeln, keine Schnittstelle nötig, die Rezeption entscheidet
E2 Zentrale Terminvergabe und Telefon Rezeption, beide	Terminwünsche annehmen, Standardfragen beantworten, weiterleiten: Kassenrezept in den Verordnungs-Check, Privatpatient zum Erstattungshinweis	**hoch:** das Telefon bindet die Rezeption an beiden Standorten	**mittel:** echte Buchung braucht Zugriff auf den Kalender der Praxissoftware
E3 Kosten- und Erstattungshinweis Rezeption, Praxis 2	aus Preisliste und allgemeinen Tarifinformationen einen verständlichen Hinweis zu Kosten und Erstattung erstellen	**mittel:** weniger Ärger und Rückfragen nach der Rechnung	**mittel bis hoch:** keine Schnittstelle, aber nur Hinweis, keine Erstattungszusage
E4 Erinnerungen an Patienten Rezeption, beide	Termin- und Ausfallerinnerungen per SMS oder E-Mail	**mittel:** weniger Leerlauf durch versäumte Termine	**hoch:** Standardfunktion, KI kaum nötig
E5 Abrechnungs-Vorbereitung Verwaltung, beide	Befunde auswerten, Absetzungen nachverfolgen, Muster nach Arzt und Fehlerart erkennen	**mittel**	**gering:** die Abrechnung liegt beim Dienstleister
E6 Therapieberichte an Ärzte Therapie, beide	aus Stichpunkten des Therapeuten einen Bericht an den verordnenden Arzt formulieren	**gering bis mittel:** fällt nicht bei jeder Verordnung an	**mittel:** Gesundheitsdaten im Freitext, fachliche Verantwortung beim Therapeuten
E7 Dienst- und Raumplanung Verwaltung, beide	Schichten und Räume über zwei Standorte planen	**gering:** bei zehn Mitarbeitenden überschaubar	**mittel**

4 Wo Regeln oder Menschen besser sind als KI

Nicht jeder Schritt braucht ein Sprachmodell. An mehreren Stellen ist eine feste Regel oder ein Mensch die bessere Wahl, und dort setzen wir bewusst keine KI ein:

Schritt	Lösung	Begründung
Fristen berechnen (Behandlungsbeginn, Unterbrechung)	feste Regel	Tage zählen ist Rechnen, keine Auslegung. Eine Regel liefert bei gleicher Eingabe immer dasselbe Ergebnis.
Arztnummer und Betriebsstättennummer prüfen	feste Regel	Beide haben ein festes Format mit neun Ziffern.
ICD-Code der passenden Diagnosegruppe zuordnen	feste Regel	Die Zuordnung folgt der Systematik der Codes. Ein Modell, das sie errät, ist eine vermeidbare Fehlerquelle.
Einheiten im Verordnungsfall summieren	feste Regel	Eine Summe ist eine Rechnung und muss exakt stimmen.
Über die Verordnung entscheiden	Mensch	Die Rezeption entscheidet, ob behandelt, nachgefragt oder korrigiert wird. Das System empfiehlt nur.
Erinnerungen versenden	Standardfunktion	Ein fester Zeitplan reicht, Sprachverständnis ist nicht nötig.

Die KI übernimmt damit nur, was Sprachverständnis verlangt: die Angaben einer Verordnung erfassen, die passende Stelle im Regelwerk finden und den Befund verständlich formulieren.

5 Entscheidung und Begründung

E1 Verordnungs-Check: erster Einsatzbereich. Er ist das einzige Feld, das bei Nutzen und Machbarkeit oben liegt. Er trifft das größte Problem, denn 90 % der Fehler und der größte Teil der 5,3 Stunden Prüfzeit pro Woche betreffen die Verordnung. Die Regeln sind öffentlich, jeder Befund kann eine Fundstelle nennen, und die Bewertung hat einen objektiven Maßstab. Er braucht keine Schnittstelle, die Eingabe läuft über Formular oder Chat. Das Risiko ist gering, weil die Rezeption entscheidet. Und der Erfolg ist messbar: Prüfzeit, Trefferquote und Nacharbeit lassen sich vorher und nachher vergleichen.

E2 Zentrale Terminvergabe: nächster Kandidat. Der Nutzen ist hoch, aber ohne Zugriff auf den Kalender der Praxissoftware bleibt es bei einer Vorqualifizierung. Dafür gibt es Standardprodukte; ein eigener Bau lohnt sich nicht.

E3 Erstattungshinweis: Ausblick. Sinnvoll für die Privatpraxis, aber mit einer klaren Grenze: ein Hinweis, keine Erstattungszusage. Über die Erstattung entscheidet die Versicherung.

E4 bis E7: nicht im ersten Umfang. Erinnerungen brauchen keine KI. Die Abrechnung liegt beim Dienstleister, Therapieberichte bergen ein höheres Datenschutzrisiko, und die Dienstplanung hat bei der Größe der Praxis wenig Hebel.

> **Die Terminvergabe als Weiche**
> Weil die Terminvergabe zentral für beide Standorte läuft, verbindet sie die Ansätze: Ein Kassenrezept geht durch den Verordnungs-Check, ein Privatpatient bekommt den Erstattungshinweis. Daraus ergibt sich die Reihenfolge späterer Ausbaustufen.

6 Der gewählte Umfang

Der erste Umfang ist der Verordnungs-Check für neue Kassenverordnungen in Praxis 1, mit der Verordnungsfall-Prüfung als wichtigstem Baustein. Feste Regeln rahmen das Sprachmodell ein: Fristen, Formate, Diagnosegruppe und Summen rechnet der Code, das Modell erfasst und formuliert. Am Ende jeder Prüfung steht die Entscheidung der Rezeption.

Ausdrücklich nicht dazu gehören eine automatische Abweisung, eine Schnittstelle zur Praxissoftware, die Abrechnung, andere Heilmittel als Physiotherapie, Privat- und BG-Verordnungen sowie jede medizinische Beurteilung. Das System prüft Regelkonformität, nicht, ob eine Therapie medizinisch sinnvoll ist. Welche Werkzeuge diesen Umfang am besten umsetzen, vergleicht Kapitel 3.

QUELLEN

- Eigene Field Study: Ist-Interview vom 16.10.2026 und Nachtrag vom 23.10.2026 (KI-Nutzung, Standorte)
- Verband der Privaten Krankenversicherung: Heilmittelerbringer, privat-patienten.de